



Pergunta

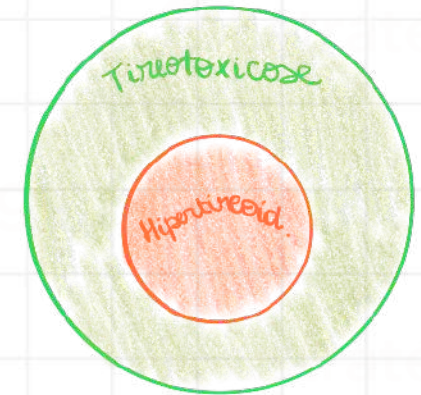


Qual é a diferença entre
hipertireoidismo e **tireotoxicose**?

Explique esses conceitos.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

- Tireotoxicose: estado de **excesso de hormônios tireoidianos (produzidos ou não pela tireoide)**; *→ pd ter uso abusivo de Puroon, tireoidite subaguda...*
- Hipertireoidismo: **excesso de hormônios tireoidianos produzidos pela tireoide.**

T3 e T4



Pergunta



Qual é a causa mais frequente de tireotoxicose?

Endocrinologia



Tireotoxicose

- adultos jovens
- autoimune → anticorpos TRAb^① que estimulam o prod hormonal

Doença de Graves.

① TRAb imita a
o TSH, se ligando aos
receptores de TSH na
tireoide e estimulando
↑ T3 e T4

▷ Sist. Imune ataca olhos → inflamação → edema e ↑ tecido orbitário

OFTALMOPATIA



Quais os principais
etiologias de Tireotoxicose ? (5)



- **Doença de Graves:** causa mais comum em adultos jovens, de origem autoimune, mediada por anticorpos contra o receptor de TSH (TRAb), que estimulam a produção hormonal de forma difusa.
- **Bócio multinodular tóxico:** geralmente em idosos, com evolução lenta e múltiplos nódulos autônomos.
- **Adenoma tóxico (doença de Plummer):** nódulo único hiperfuncionante.
- **Tireoidites:** subaguda (granulomatosa), silenciosa ou pós-parto, nas quais há destruição do tecido tireoidiano e liberação de hormônios.
- **Causas iatrogênicas/exógenas:** uso excessivo de levotiroxina, exposição a amiodarona (rica em iodo) ou contraste iodado.
- **Outras causas raras:** *struma ovarii*, metástases funcionantes de carcinoma tireoidiano, adenoma hipofisário secretor de TSH.



①
Bócio
multinodular tóxico



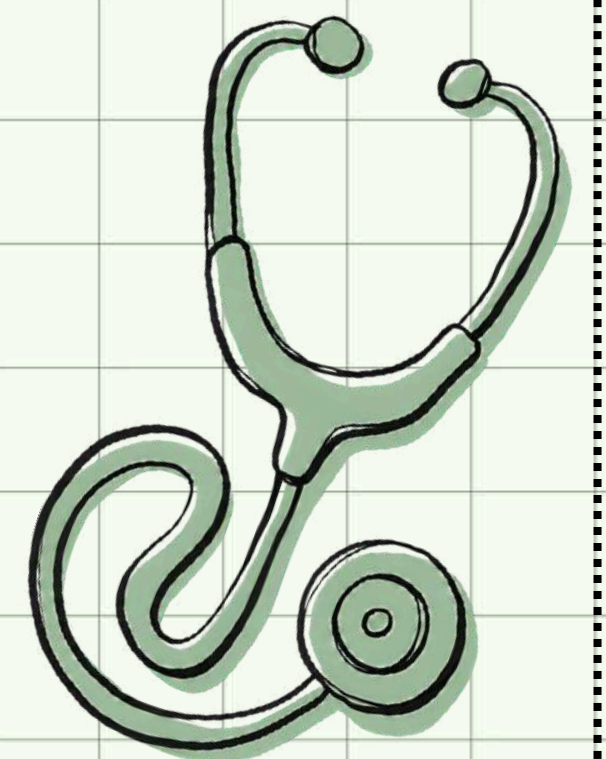
②
Doença de Graves



③
Adenoma tóxico



Qual o quadro clínico
da tireototoxicose?



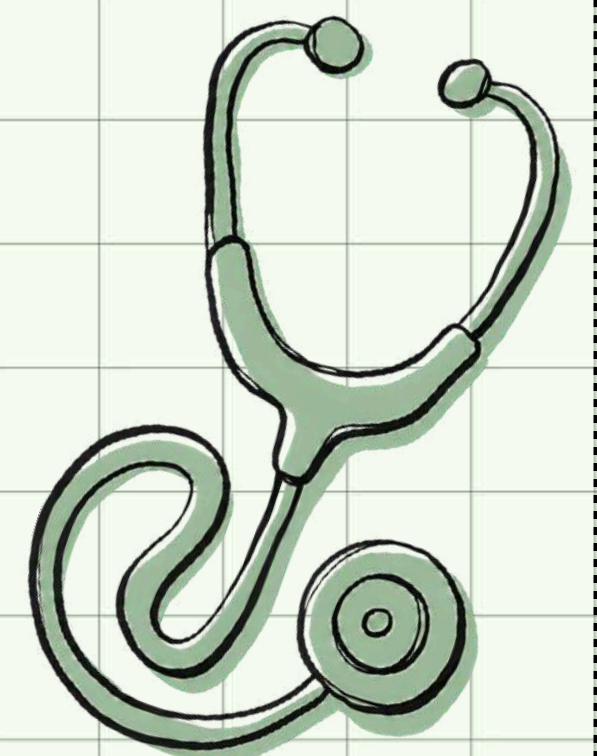
Os **sintomas típicos** são relacionados a uma ativação adrenérgica excessiva, popularmente associada a um “metabolismo acelerado”, como consequência do excesso de hormônios tireoidianos:

- Perda de peso
- Intolerância ao calor
- Sudorese excessiva
- Palpitações
- Tremor fino
- Nervosismo
- Ansiedade
- Fraqueza muscular proximal
- Aumento da frequência evacuatória, sem necessariamente diarreia
- Em mulheres, podemos ter alterações menstruais, como oligomenorreia ou amenorreia

Idosos podem apresentar um quadro atípico, como o chamado “hipertireoidismo apático”, caracterizado por fadiga, depressão e perda de peso sem os sintomas clássicos de hiperatividade simpática.

Ao **exame físico**, é comum encontrar pele quente e úmida, taquicardia ou fibrilação atrial, hipertensão sistólica, tremor fino e hiperreflexia.

Especialmente na doença de Graves, a principal etiologia, podemos encontrar sinais específicos, como orbitopatia infiltrativa (exoftalmia, retração palpebral, edema periorbitário) e dermopatia (mixedema pré-tibial).





Pergunta



Quais são os níveis esperados dos testes de função tireoidiana em pacientes com hipertireoidismo clínico?

↳ ou primário

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

↓TSH, ↑T3 e ↑T4.



Flashcard

Pergunta



O que é o fenômeno
de Jod-Basedow?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

É um **hipertireoidismo** decorrente do **aporte de iodo** (p. ex.: uso de ***amiodarona**) em uma tireoide predisposta ao fenômeno.

* antiarritmico com ↑ dose de iodo





Pergunta



Quais são os níveis esperados dos testes de função tireoidiana em pacientes com hipertireoidismo subclínico?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

→ Só 1 exame alterado ñ é diag. → repete d 6-12 sem.
Pode ter sintomas de hipertireoidismo

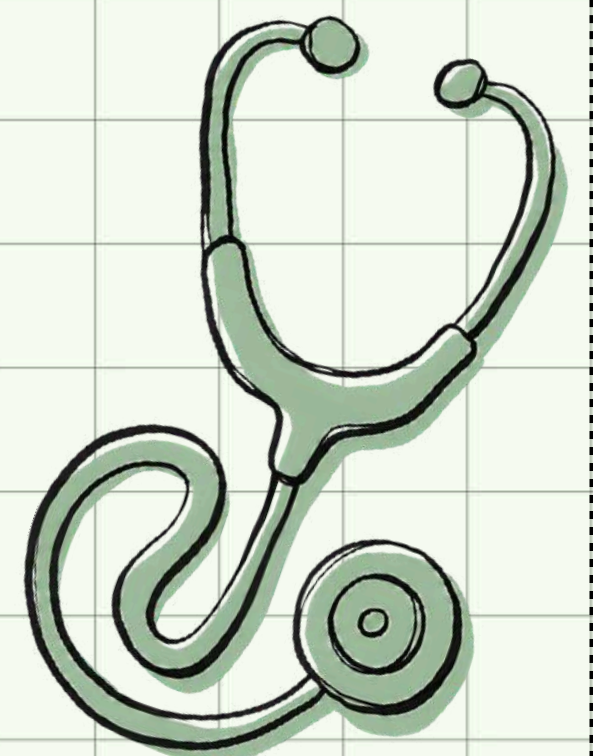
↓TSH, T3 e T4 normais.

→ TSH é muito sensível, ent. se T3/T4

ficam no limite superior ou ↑ um pouco,
ele já tem feedback e diminui → T3/T4 ficam normais,
mas podem evoluir

Quais os exames + importantes
pra determinar curso de tireotoxicose? (3)

Explique o que cada um evidencia.



• **Cintilografia de tireoide:** diferencia causas com aumento da captação (Graves, adenoma tóxico, bócio multinodular) daquelas com captação baixa (tireoidite, iatrogênico).

• **Ultrassonografia:** útil para avaliar nódulos e volume glandular.

• **Anticorpos TRAb:** confirmam doença de Graves e ajudam a prever recidiva após tratamento

Um cuidado importante é a **interferência por biotina**, comum em suplementos vitamínicos, que pode causar falsos resultados nos imunoensaios, mimetizando hipertireoidismo.

usado p/ fortalecer
ossos e saúde
geral

• A cintilografia avalia o **metabolismo e o funcionamento** da tireoide medindo a absorção de um marcador radioativo usado na produção de hormônios.

• **O que ela identifica:**

- A causa exata do hipertireoidismo.
- A natureza dos nódulos: **Quentes** (hiperativos, quase sempre benignos) ou **Frios** (inativos, necessitam de investigação para afastar malignidade).
- A localização e o formato da glândula.

→ punção / PAAF

• **Captação Aumentada (Hiper captação / "Quente"):**

- A glândula está **trabalhando em excesso** e produzindo muito hormônio.
- *Exemplos:* Doença de Graves (captação difusa na glândula toda) ou Nódulos Tóxicos (captação localizada).

• **Captação Reduzida (Hipocaptação / "Fria"):**

- A glândula **não está captando iodo**, seja por inflamação, lesão celular ou bloqueio por substâncias externas.
- *Exemplos:* Tireoidites (onde a glândula libera hormônio acumulado por inflamação, mas não produz novos), uso recente de contraste iodado/medicamentos, ou hipotireoidismo.



Pergunta



Diagnóstico provável:

mulher de 35 anos apresenta perda de peso não intencional, sudorese, intolerância ao calor, taquicardia, fraqueza, exoftalmia e bócio difuso.

Hemoglobina = 12,8 g/dL, creatinina = 0,7, sódio = 140 mg/dL, potássio = 4 mg/dL, ↓TSH, ↑T4 livre.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Doença de Graves (hipertireoidismo primário).

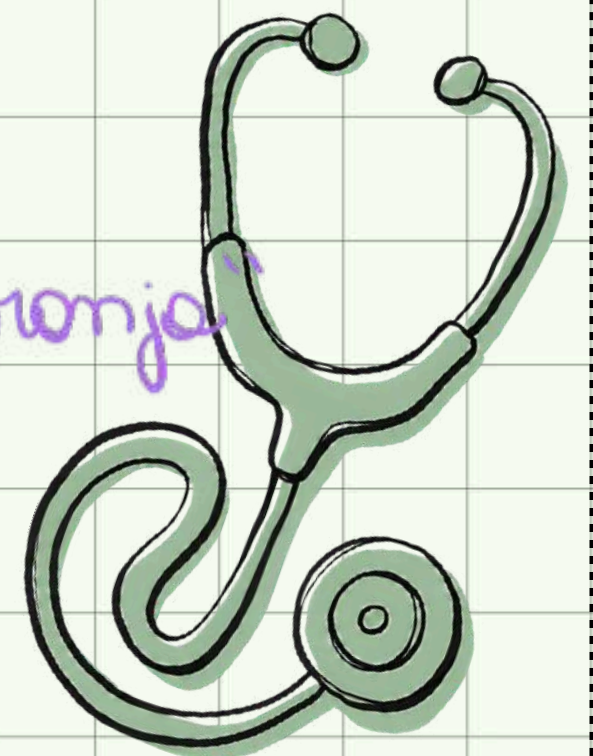
OBS: É 5-10x + frequente em mulheres; pico 20-40 anos

Explique como ocorre a
fisiopatologia da
Doença de Groves. (6)

Pq ocorrem sintomas oculares^(A)
e cutâneos^(B)?

(A) Proptose / exoftalmia, retroção palpebral, diplopia, edema periorbitário

(B) Dermopatia com espessamento, endurecimento, aspecto "coxa de laranjeira"
com alteração da coloração da região



Doença de Graves

Fisiopatologia

Doença autoimune em que autoanticorpos estimuladores contra o receptor de TSH (TRAb) imitam a ação do TSH, causando hiperplasia e hiperfunção da tireoide, com aumento de T3/T4 e manifestações extratireoidianas, principalmente orbitopatia.

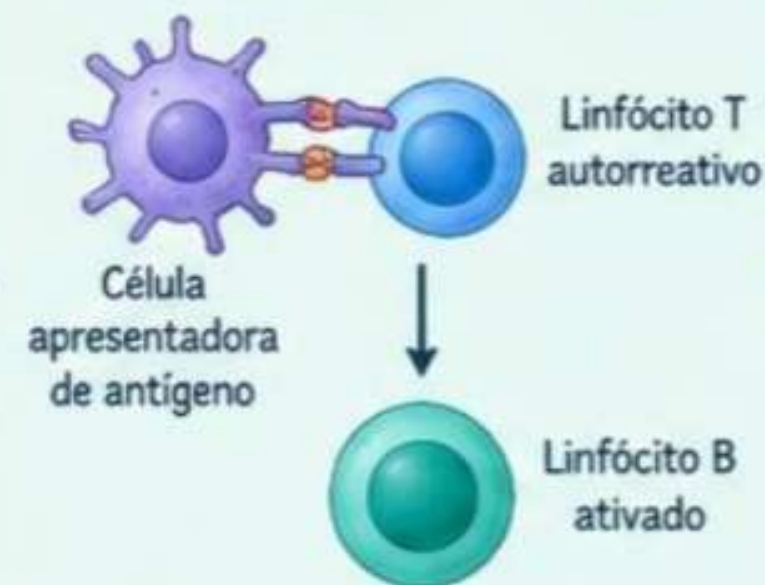
1 Predisposição genética e fatores ambientais



- Predisposição genética
- Tabagismo
- Estresse físico/emocional
- Infecções
- Excesso de iodo
- Alguns medicamentos
- Pós-parto

Esses fatores podem desencadear a perda da tolerância imunológica em indivíduos predispostos.

2 Perda da autotolerância imunológica



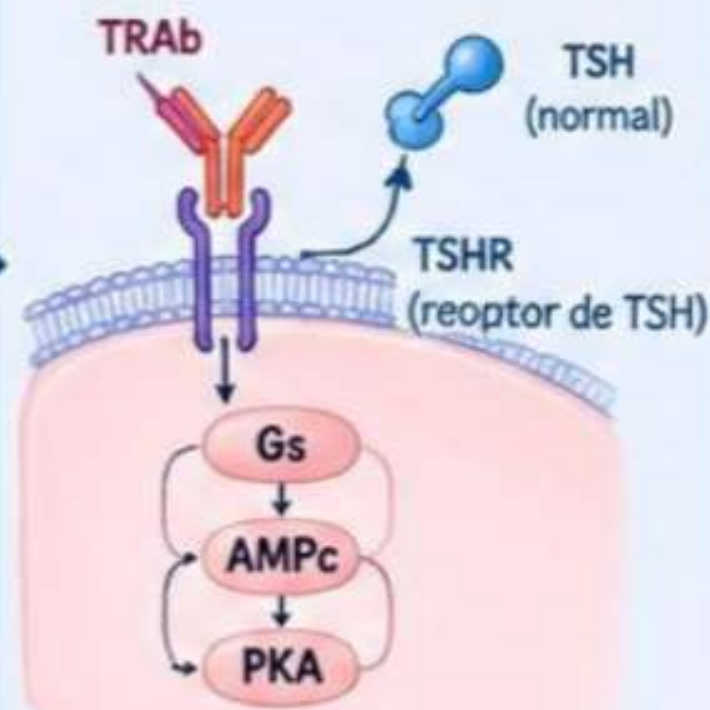
O sistema imune passa a reconhecer antígenos da tireoide (principalmente o receptor de TSH) como "estranhos".

3 Produção de TRAb



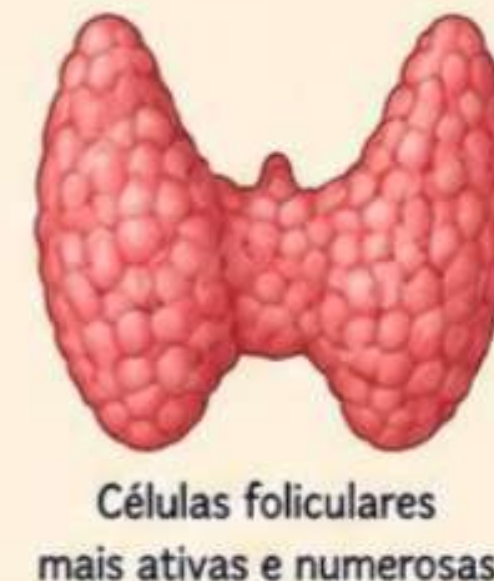
Os linfócitos B passam a produzir anticorpos estimuladores contra o receptor de TSH.

4 TRAb imita o TSH e ativa o receptor de TSH (TSHR)



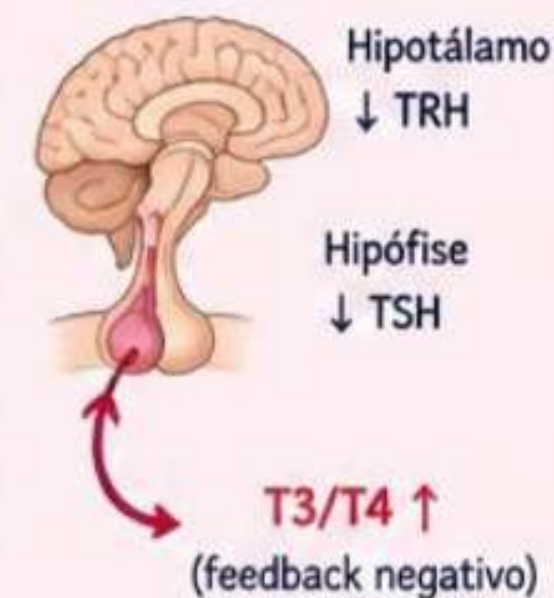
Isso ativa a via Gs/AMPC, estimulando a função da célula folicular tireoidiana.

5 Hiperplasia e hiperfunção da tireoide



Resultado:
↑ síntese e secreção de T3 e T4 (bócio difuso)

6 Feedback negativo e tireotoxicose



Apesar do TSH estar baixo, a tireoide continua produzindo hormônio devido ao estímulo do TRAb.

OBS: fibroblastos são células do tecido conjuntivo super abundantes q atuam na sustentação do corpo
↳ produzem colágeno (dá firmeza), elastina e á. hialurônico (GAG que dá hidratação)
↳ especificom. os fibroblastos das regiões orbitais e pré-tibial (conela) têm receptores de TSH (por questões embrionárias...)
↳ TRAb interage c/ esses receptores ↑ produção de GAGs

TRAb → fibroblastos

↑ GAGs + inflamação

acúmulo de líquido

denso, preso, de difícil drenagem

Orbitopatia infiltrativa e Dermopatia / Mixedema pré-tibial



① GLICOSAMINOGLICANO = longa cadeia de carboidratos hidrofílicos



Pergunta



Qual é o autoanticorpo tipicamente positivo na doença de Graves?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Anticorpo contra o receptor de TSH (TRAb).



→ Thyrotropin/TSH Receptor Antibody
→ Tem ação estimuladora



Pergunta



Qual é o padrão esperado na cintilografia da tireoide de um paciente com hipertireoidismo primário (em particular na doença de Graves)?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

**Bócio com captação
aumentada e difusa.**





Pergunta



Qual é o tratamento farmacológico de escolha para reduzir rapidamente os sintomas de tireotoxicose? (1)

Fale 2 exemplos desses fármacos.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

OBS: ↑ T3/T4 deixam tecidos + sensíveis às catecolaminas (adrenalina e noradrenalina)

Betabloqueador*

(p. ex.: atenolol ou propranolol).

25-50mg/dia

40mg 2-3x/dia

* esse ainda inibe conv. perif. de T4 → T3 (que é + potente)
↳ começa com PROP

* É um bloqueador de receptor β-adrenérgico, ↓ efeitos do hipertireoidismo como taquicardia, tremor, palpitação, sudorese...



Pergunta



Quais são os dois fármacos de escolha para a redução da síntese de hormônios tireoidianos nos pacientes com tireotoxicose?

E em caso de gestantes?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Classe
das
Tionomidas

Ti reside

→ Malformações cong. no 1º tri gestacional
→ = Tapozol dose inicial de 10-30mg/dia

1. **Metimazol** (em geral, é a medicação de escolha);

2. ^{=PTU} **Propiltiouracil.**
→ esse ainda inibe conv. perif. de T4 → T3 (que é + potente)
→ começa cl PROP

→ Tem + colaterais (hepatotox, vasculite)

→ Indicado no 1º tri gestacional e Tempstade tireoidiana



Estratégia
MED



Pergunta



Quais são os **dois principais**
tratamentos não farmacológicos
da **doença de Graves**?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

- **Iodo radioativo;** (radioiodo)
- **Tireoidectomia total.**

↓
Indicado em bólios voluminosos, susp. de malign., contra-indic. de radioiodo ou efeitos adversos às drogas



Pergunta



Qual é a complicação mais comum do tratamento da doença de Graves com iodo radioativo?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Hipotireoidismo.



Estratégia
MED



Pergunta



Qual é o tratamento da doença de Graves **totalmente contraindicado** em **gestantes**?

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

**Tratamento com
iodo radioativo.**



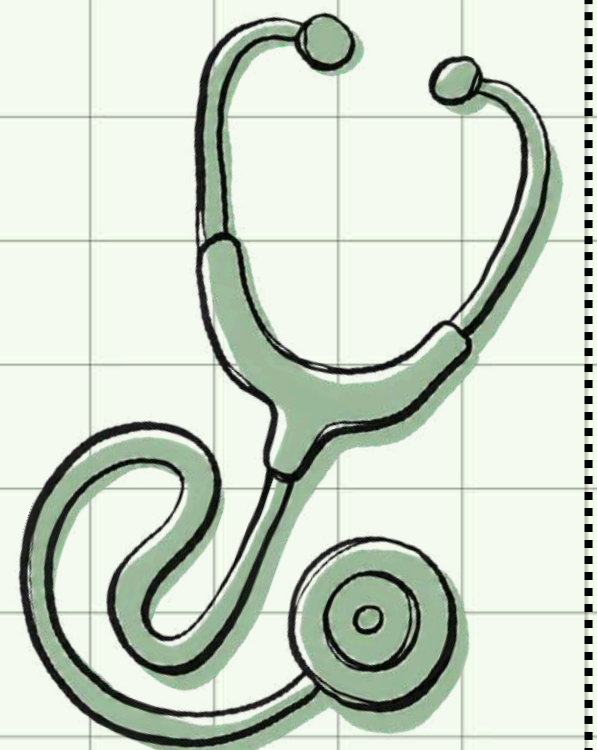
Sobre a Doença de Plummer

↳ O que é

↳ Apresentação clínica

↳ Diagnóstico

↳ Tratamento



BÓCIO UNINODULAR TÓXICO ou DOENÇA DE PLUMMER ou NÓDULO AUTÔNOMO ou ADENOMA TÓXICO

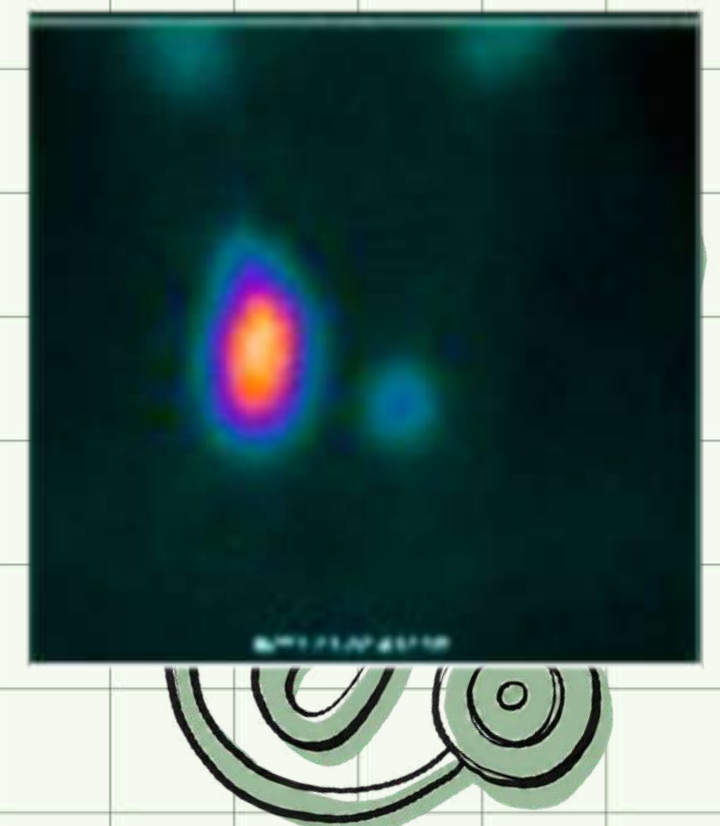
→ Adenoma = tumor benigno em local de glândula

→ Adenoma $\equiv$ Autônomo $\equiv$ Plummer // Plummer = Único = Uninodular

- Nódulo único na tireoide q começa a prod. T3/T4 indep. do TSH, caracterizando um hipertireoidismo
- Apresentação: + insidiosa; nódulo único palpável no ex. físico ^{→ > 3 cm}
↳ sintomas gerais de hipertireoidismo
- Diagnóstico: cintilografia c/ nódulo quente / hiperceptante c/ ^{laranja / vermelho} supressão de capt. no resto da glând.

OBS: TRAb $\ominus$

- Tratamento: Radioiodo, Tireoidectomia parcial / hietectomia ou antitireoidíones (Tiozóis = metimozol)



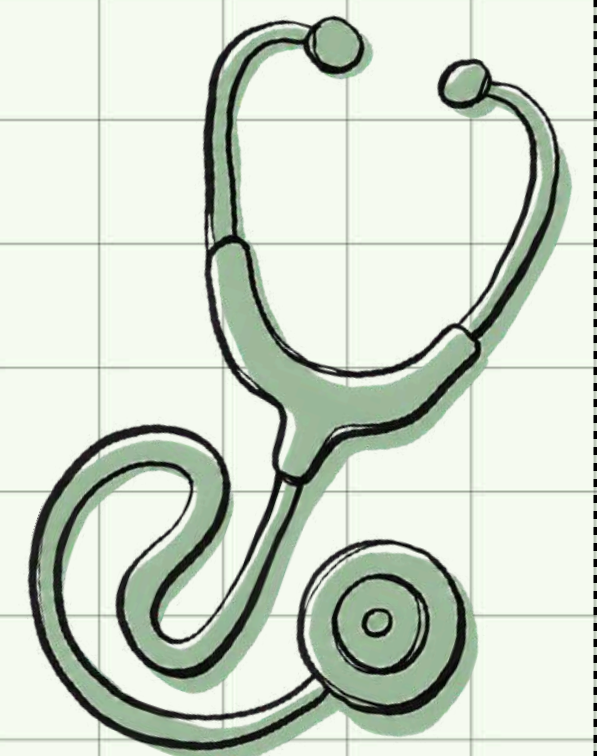
Sobre a Tireoidite de Rubein

↳ O que é / fisiopatologia (2)

↳ Quadro Clínico (4)

↳ Diagnóstico (3)

↳ Tratamento (3)



TIREOIDITE SUBAGUDA DE QUERVAIN (ou GRANULOMATOSA)

* PAIN (ou reação pós viral)
↳ início gradual

- **Fisiopatologia:** Reação inflamatória granulomatosa pós-viral (associada a Coxsackie, Influenza, Adenovírus, SARS-CoV-2, etc.) em indivíduos geneticamente predispostos (HLA-B35). Ocorre ruptura dos folículos com extravasamento massivo de hormônios pré-formados na circulação.
- **Fases Clínicas:**
 - 1. Fase de **Tireotoxicose** (1 a 2 meses): Liberação mecânica de T3/T4 sem hiperfunção sintética.
 - 2. Fase **Eutireoidiana transitória**.
 - 3. Fase **Hipotireoidiana** (1 a 2 meses): Depleção dos estoques hormonais até a recuperação tecidual.
 - 4. **Recuperação:** A maioria retorna ao eutiroidismo normal. → cura espontânea
- **Diagnóstico:** VHS e PCR significativamente elevados; TSH suprimido com T4L alto na fase inicial. **Cintilografia:** captação de iodo praticamente nula (< 1%-2%), o que a diferencia da Doença de Graves.
- **Tratamento:** Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) em casos leves; Prednisona em doses moderadas/altas para dor intensa. Beta-bloqueadores (ex: Propranolol) controlam os sintomas adrenérgicos na fase de Tireotoxicose.



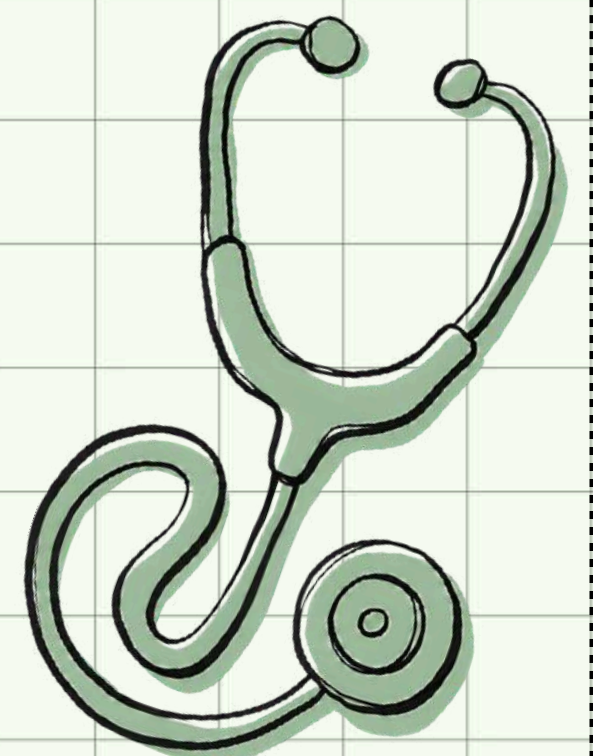
Sobre a Tireoidite Linfocítica Subaguda

↳ O que é / fisiopatologia (2)

↳ Quadro clínico (3)

↳ Diagnóstico (3)

↳ Tratamento (3)



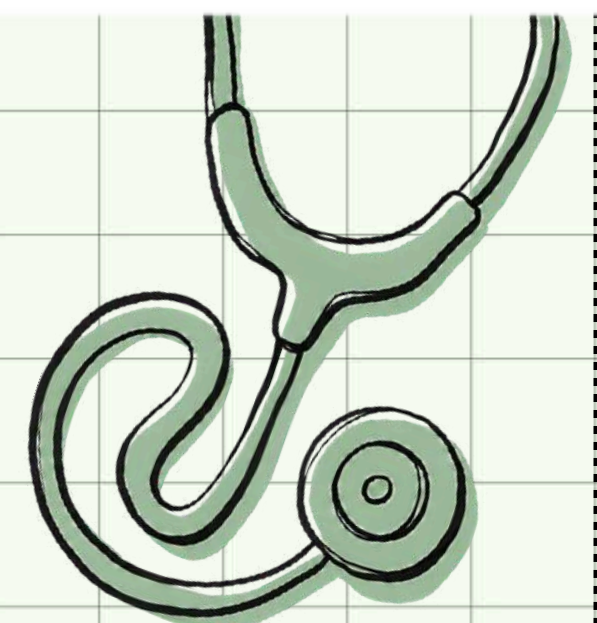
TIREOIDITE L^{INDOLOR} INFOCÍTICA SUBAGUDA ou INDOLOR / SILENCIOSA

↳ são cels de defesa ⇒ autoimune

→ hipotireoidismo

- **O que é:** é considerada uma variante da Hashimoto, por ter componente autoimune. Não se sabe ao certo qual o gatilho para desenvolvimento.
- **Fisiopatologia:** Variante da doença autoimune (com infiltrado linfocítico), em que há liberação transitória de hormônios por destruição folicular (mecanismo destrutivo, não produtivo). Quando surge no primeiro ano após a parto/aborto, denomina-se **Tireoidite Pós-Parto**.
- **Diagnóstico:** TSH baixo e T4L elevado com ausência de dor à palpação e VHS/PCR normais ou discretamente elevados (diferenciando de De Quervain). Anti-TPO pode ser positivo em até 60-80% dos casos. A cintilografia apresenta captação de iodo muito baixa/nula.
- **Tratamento:** Não se utilizam drogas superantitireoidianas (como Metimazol), pois não há hiperprodução. Usam-se beta-bloqueadores na fase tirirotóxica e reposição temporária de Levotiroxina se a fase hipotireoidiana for sintomática.

↳ Quadro Clín: SEM dor! Mas pode ter fase tirirotóxica c/ sints adrenérgicos e fase hipo c/ cansaço e desânimo



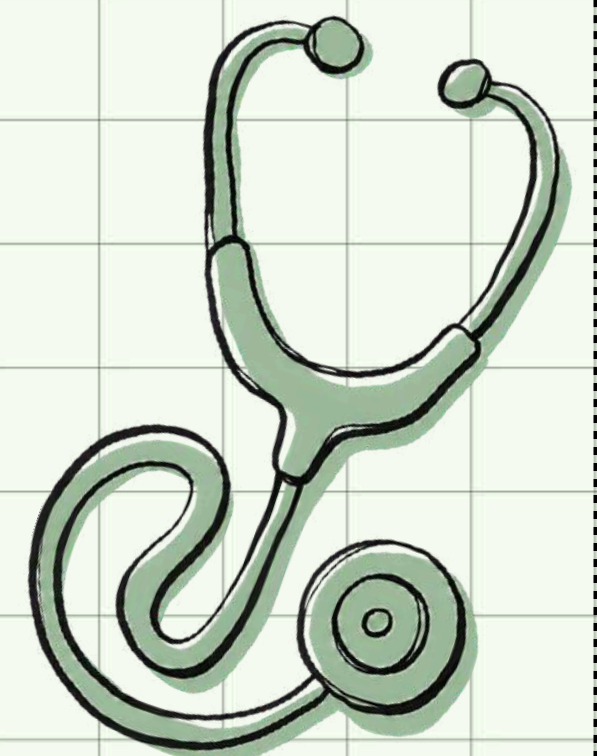
Sobre a Tireoidite Aguda

↳ O que é / fisiopatologia (3)

↳ Quadro Clínico (4)

↳ Diagnóstico (5)

↳ Tratamento (2)



TIREOIDITE AGUDA ou INFECIOSA AGUDA

↳ + súbito

→ 70% dos casos

- **Fisiopatologia:** Infecção bacteriana (frequentemente *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* ou anaeróbios), fúngica ou por micobactérias. É rara devido ao alto teor de iodo na glândula, rica vascularização e drenagem linfática eficiente. Frequentemente associada a anomalias anatômicas (ex: fístula do seio piriforme em crianças) ou imunossupressão.
- **Sintomas principais:** aumento unilateral e doloroso da tireoide, com possível irradiação para mandíbula e ouvido ipsilaterais, febre alta, linfonodomegalia cervical e piora do estado geral
- **Diagnóstico:** Leucocitose com desvio à esquerda; PCR/VHS elevados. Função tireoidiana (TSH/T4L) geralmente mantida normal. USG de pescoço evidencia coleção líquida/abscesso. Puncção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) para gram e cultura confirma o agente infeccioso.
- **Tratamento:** Antibioticoterapia sistêmica de amplo espectro de início imediato e drenagem cirúrgica ou guiada por USG do abscesso.





Pergunta



Diagnóstico provável:

mulher de 20 anos apresenta tireoide discretamente aumentada, com dor à palpação local. Refere febre, calafrios, mal-estargeral, tosse e coriza há 5 dias. Hemoglobina = 12,8 g/dL, VHS = 40 mm/h, leucócitos = 16.000, plaquetas = 260.000, TSH = 0,1 mUI/L, T4 livre = 2,7 ng/dL.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

**Tireoidite subaguda
(de Quervain).**



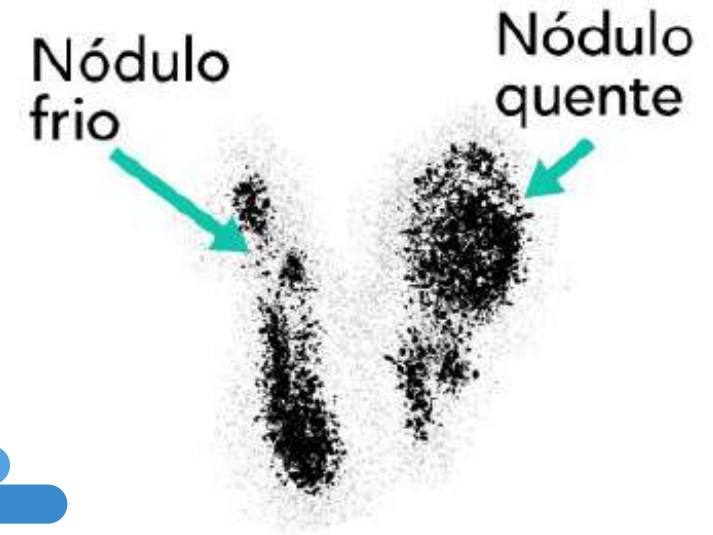


Pergunta



Diagnóstico provável:

homem de 62 anos apresenta taquicardia, irritabilidade, perda de peso e fibrilação atrial. $\downarrow$ TSH, $\uparrow$ T4 livre discretamente aumentado, $\uparrow$ T3, TRAb negativo e anti-TPO negativo.



Cintilografia da tireoide do paciente.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Bócio multinodular tóxico.

- Comum em idosos
- Quadro insidioso e + brando
- + freq em lugares c/ deficiência crônica de iodo
- TRAb $\ominus$



Estratégia
MED



Pergunta



Qual é o exame de escolha inicial para a investigação de um nódulo tireoidiano percebido no exame físico?

E qual o 2º exame a depender do valor desse TSH?

Endocrinologia

1º exame:
TSH

TSH ↑ ou normal

TSH ↓

USG da Tireoide

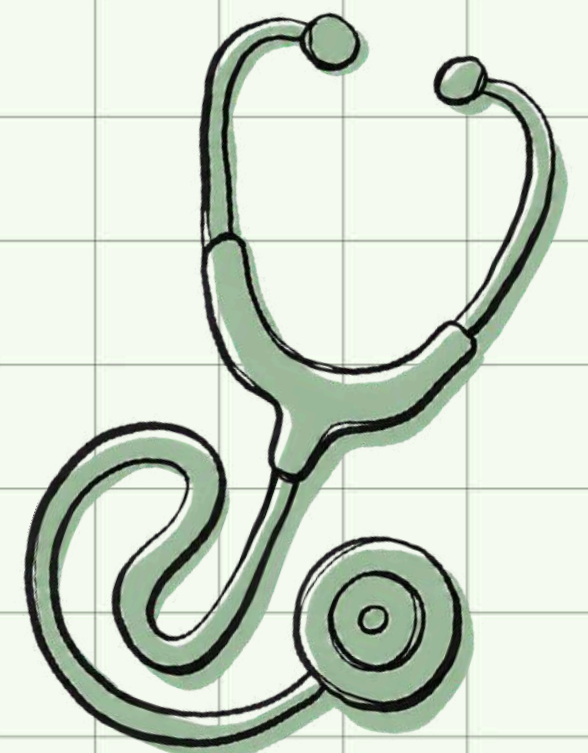
Cintilografia

Avaliar anatomia do nódulo
para julgar aspectos de malignidade
e necessidade de PAAF
(punção aspirativa por agulha fina)

Nódulo
frio

Nódulo
quente

Tto pl
hipertireoidismo





Pergunta



Diagnóstico provável:

mulher de 28 anos queixa-se de taquicardia, intolerância ao calor e perda de peso, mas não apresenta bócio nem exoftalmia. Teve um parto normal há 6 meses. ↓TSH, ↑T4, TRAb negativo, anti-TPO positivo, cintilografia da tireoide evidencia baixa captação de iodo.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Nosso corpo tem q. adotar novo sist. autoimune
p/ conseguir lidar q. bebê → nisso ele pode desregular
e atacar tireoide → libera horm. estocados por
destruição das cels foliculares tireoidianas *

Tireoidite pós-parto.

* Destruição libera estoques → ↑T3/T4 → hipertireoidismo
↳ Cels destruídas ã produzem + T3/T4 → fase hipotireoidismo
↳ Dps recupera fç normal

OBS: TRAb → Graves

anti-TPO → Hashimoto

cintila baixa pq ã há produção e sim destruição



Pergunta



Diagnóstico provável:

homem de 25 anos queixa-se de intolerância ao calor, taquicardia, perda de peso e tremores finos de extremidades há 3 semanas. TSH = 0,1 * mUI/L, T4 livre = 2,5 ng/dL, anti-TRAB negativo e ausência de captação na cintilografia.

* Ref. TSH normal 0,4 a 4,5
T4L normal 0,7 a 1,8

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Tireotoxicose factícia.

↘ excesso de T3/T4 por ingestão externa
por automedicação irregular (suplem. ou emagrecedores)
ou manipulação psiquiátrica



Pergunta



Diagnóstico provável:

homem de 60 anos queixa-se de intolerância ao calor, taquicardia, perda de peso e tremores finos de extremidades. É hipertenso (em uso de enalapril e hidroclorotiazida) e tem fibrilação atrial (em uso de amiodarona). ↓TSH, ↑T4 livre, TRAb negativo e anti-TPO negativo.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Tireotoxicose induzida pela amiodarona.

↙ antiarrítmico com ↑ dose
de iodo





Pergunta



Diagnóstico provável:

menino de 2 anos apresenta dificuldade para ganhar peso e altura, além de agitação. Ao exame físico nota-se bócio difuso. $\uparrow$ TSH, $\uparrow$ T3 total, $\uparrow$ T4. A mãe e a avó materna também tem histórico de bócio.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

O diagnóstico mais provável é **resistência ao hormônio tireoidiano beta (RTH β)**, também chamada **síndrome de Refetoff**, provavelmente por uma variante no gene **THRB**, com **herança autossômica dominante**.

Deve-se suspeitar de RTH β quando **T4 e T3 estão genuinamente elevados**, mas o **TSH permanece inadequadamente normal ou elevado**; a avaliação deve incluir testes tireoidianos nos familiares de primeiro grau e sequenciamento do gene **THRB**. *European Thyroid Journal*

Por que esse diagnóstico é provável:

- Na doença de **Graves**, **T3 e T4 elevados** geralmente **suprimem o TSH**; neste caso, o TSH também está elevado.
- Na RTH β , a **hipófise é parcialmente resistente** ao hormônio tireoidiano e **continua produzindo TSH**, **estimulando a tireoide** e causando **bócio difuso**.
- A **resistência é variável** entre os **tecidos**: algumas **regiões** podem comportar-se como **hipotireoidismo**, enquanto **outras** respondem ao **excesso hormonal**. Isso pode explicar a **combinação de baixo ganho ponderoestatural e agitação/hiperatividade**. *Nutrients, The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*
- O acometimento da **mãe e da avó materna favorece fortemente** uma transmissão familiar **autossômica dominante**. *European Thyroid Journal, Metabolism*



Pergunta



Diagnóstico provável:

mulher de 28 anos apresenta taquicardia, intolerância ao calor, perda de peso, tremor fino de extremidades e hemianopsia bitemporal. $\uparrow$ TSH, $\uparrow$ T3 e $\uparrow$ T4. A tomografia evidenciou lesão selar condizente com adenoma hipofisário.

Endocrinologia

Resposta



Tireotoxicose

Tumor benigno da glândula hipófise
que secreta TSH inadequadamente, gerando
hipertireoidismo central

Adenoma hipofisário produtor de TSH.

(=TSHoma)

Se tumor ficar
grande por ter cefaleia,
alt. visuais e outros defeitos
horiz. por compressão da
hipófise e adjacentes



Pergunta



Qual é o tratamento usual do adenoma hipofisário produtor de TSH? (1)

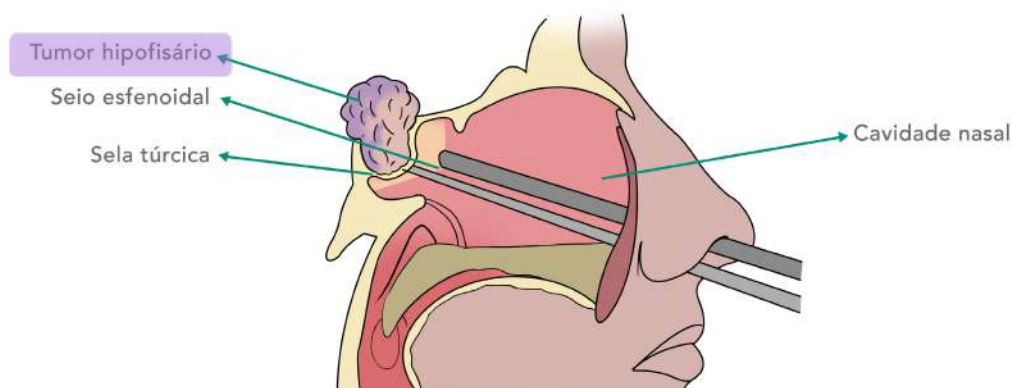
Endocrinologia



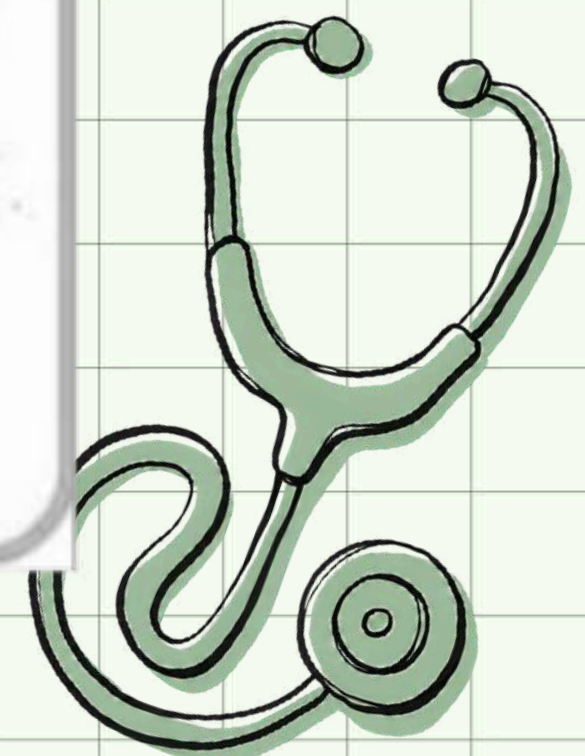
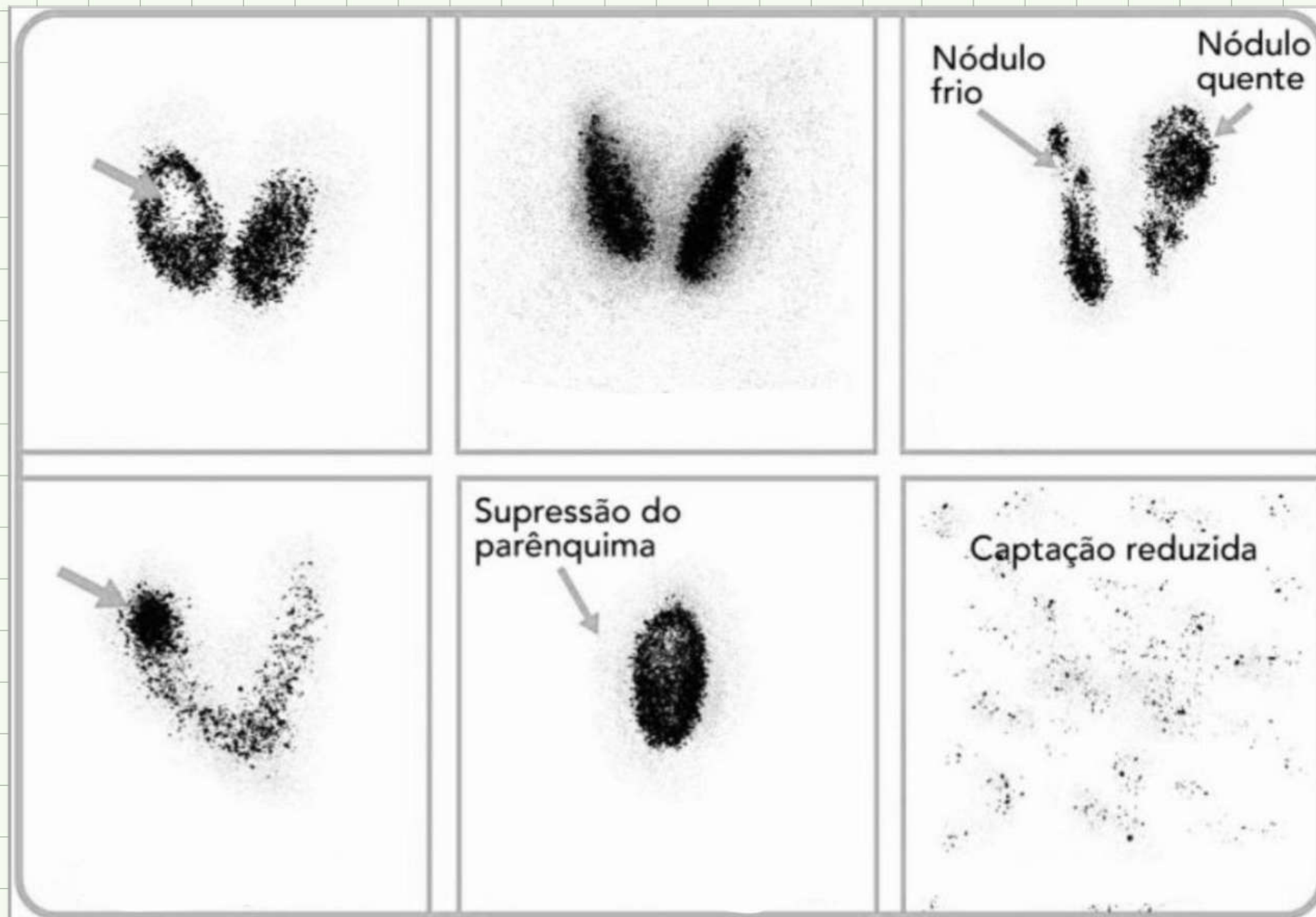
Tireotoxicose

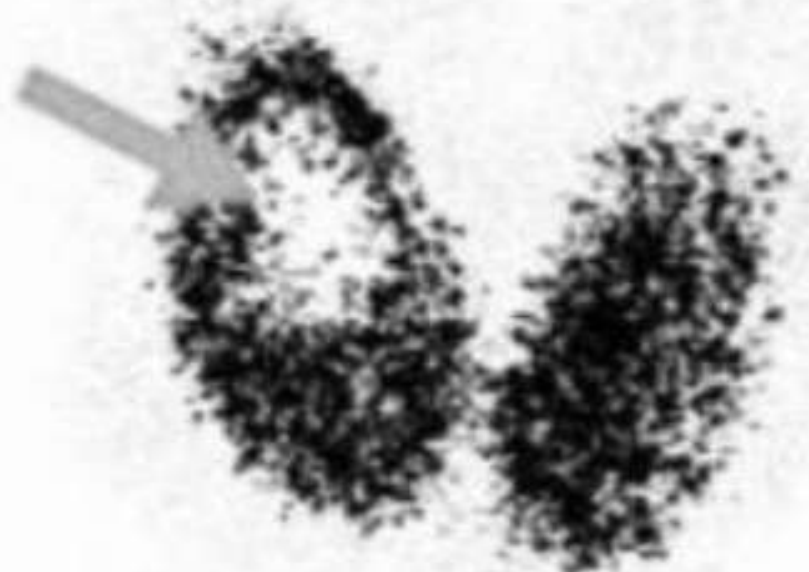
Ressecção transesfenoidal do tumor.

ABORDAGEM CIRÚRGICA TRANSESFENOIDAL



Identifique cada alteração tireoidiana
pelos cintilografios

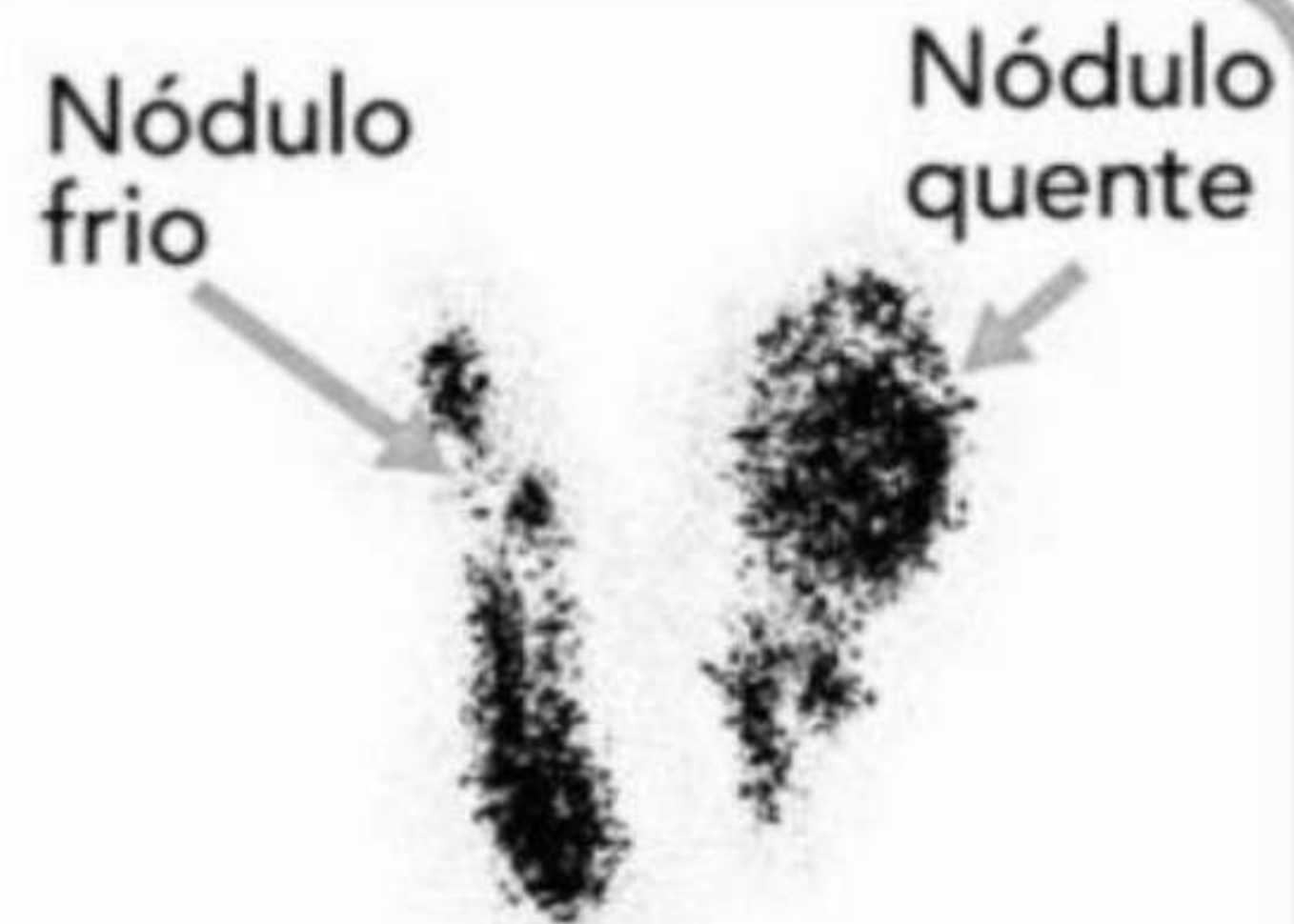




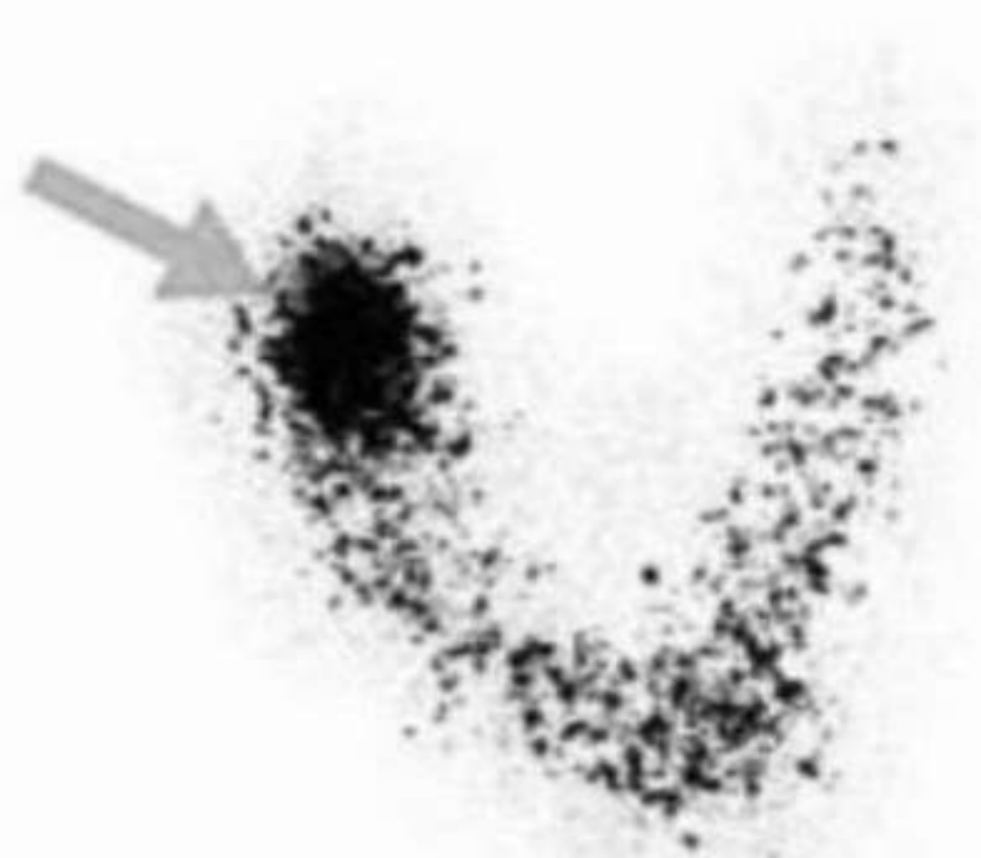
Nódulo frio



Doença de Graves



**Bócio Multinodular
tóxico**



Nódulo quente

Supressão do
parênquima



Nódulo autônomo



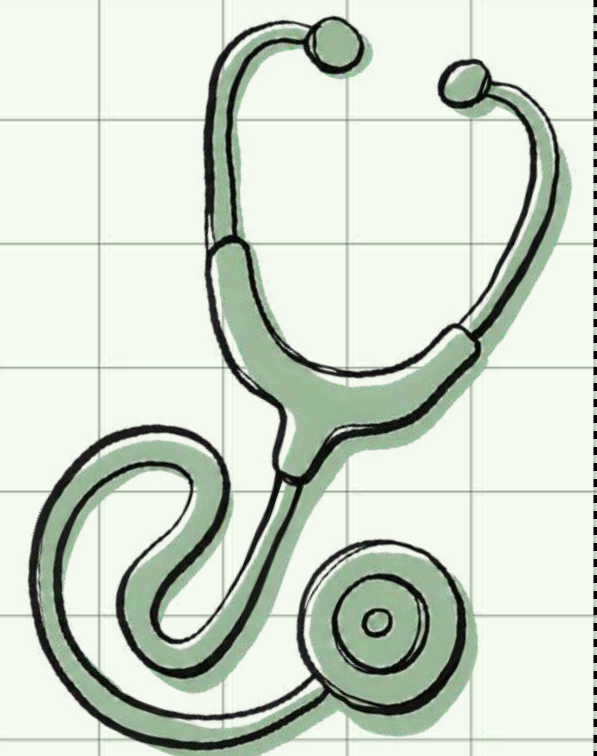
Tireoidite

Paciente q febre alta ($>38,5^{\circ}\text{C}$), Taquicardia
grave, psicose / confusão mental, vômitos,
dor abdominal e icterícia

Tem antecedente prévio de hipertireoidismo
e etilismo (em tentativa de redução).

Qual o provável diagnóstico?

Qual o manejo imediato? (4)



CRISE TIREOTÓXICA

ou

TEMPESTADE TIREOIDIANA

→ É emergência endócrina rara e potencialm. fatal, por descompensação aguda do hipotireoidismo

↳ geralm. optilho c/
infecção, trauma, cirurgia,
suspensão abrupta de
antitireoidianos.

É importante, nesse caso, realizar diagnóstico diferencial com outras etiologias com apresentação semelhante, como: sepse, feocromocitoma, síndrome neuroléptica maligna e abstinência alcoólica.

O manejo é imediato e inclui quatro pilares:

- **Controle adrenérgico:** beta-bloqueadores (por exemplo, propranolol).
PROPILOLIDOL
- **Inibição da síntese hormonal:** tionamidas (PTU preferido inicialmente, por também bloquear conversão periférica de T4 em T3).
- **Bloqueio da liberação hormonal:** iodo inorgânico (lugol ou iodeto de potássio), administrado 1 hora após a tionamida.
- **Redução da conversão periférica e resposta inflamatória:** corticoides (hidrocortisona ou dexametasona).

Medidas de suporte incluem hidratação vigorosa, controle da hipertermia, antibióticos se houver foco infeccioso e suporte intensivo em UTI. É importante destacar que a mortalidade permanece significativa mesmo com tratamento adequado.